

אסדרת מערך התמריצים במכרז הסיעוד

שלב ב' – גיבוש חלופות תמריצים
27.06.2022

תוכן עניינים

3-11	הקדמה	01
12-17	אזורי השפעה ואופן הניתוח	02
18-33	ניתוח בעיות ופתרונות בהתאם לאזורי השפעה	03
34-35	צעדים להמשך	04

רקע לפרויקט



החלטת הממשלה לוותה בהקמת וועדה בין-משרדית. מטרות הוועדה היו:



הגדרת תפקידים

גיבוש הגדרות תפקידים מחודשות למטפלים, כולל מסלולי הכשרה וקידום



הכשרה

גיבוש תפיסת הכשרה וקביעת סטנדרט רצוי להתמקצעות



מודל יישום והטמעה

גיבוש מודל לתוכנית יישום והטמעה, כולל הצבת יעדים

המטפלים הישראלים בזקנים

טיוטת המלצות הוועדה הבין-משרדית, אוגוסט 2021

החלטת הממשלה 43 - "מפת דרכים לענף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים" **באה לקדם שינויים מהותיים בענף המטפלים בזקנים**, לאור פערים גדלים והולכים בין איכות הטיפול והיצע המטפלים לבין צרכיהם המורכבים והגוברים של הזקנים.

במסגרת החלטת הממשלה התקבלו החלטות ליישום אשר מטרותיהן העיקריות הן:

1. מעבר לטיפול מותאם להזדקנות מיטבית, **למניעת הידרדרות ולשיקום**
2. שיפור **איכות הטיפול** שהמטפלים מעניקים לזקנים סיעודיים
3. הגדלת **היצע המטפלים**
4. הגדלת **הפריון של המטפלים**

טיוטת המלצות הוועדה*



הקמת מערך תמיכה למטפלים

מערך תמיכה למטפלים במתכונת קבוצות תמיכה, כאשר ההשתתפות בקבוצת התמיכה תתוגמל בשכר



תמריצי שכר למטפלים

השתתפות בהכשרות תיחשב כעבודה ותתוגמל בשכר, תיתכן עלייה בשכר ע"פ דרגת המטפל



פיתוח הכשרות, וקביעת סטנדרטים לגופי הכשרה

פיתוח קורסים להכשרה תואמת דרגה



הגדרה חדשה לתפקיד המטפל ודרגות קידום

אופק תעסוקתי, הרחבת תחומי אחריות, והכרה במטפל כשותף במערך המקצועי



גיבוש תמריצים לשינוי המערכת לדוחקת תלות

שינוי במבנה התמריצים במטרה לעודד טיפול דוחק תלות והתמקצעות של כוח האדם



פיתוח מענים מותאמים לבני משפחה מטפלים

הנגשת מידע לבני המשפחה והפנייה שלהם לשירותים המיועדים עבורם



הקמת מערך פיקוח ובקרה

חיוב נותני השירות להליך מדידה פנימי יחד עם הקמת מערך מדידה ובקרה חיצוני



פיתוח מנגנונים לשיתוף מידע

שילוב מידע מבטל"א למטפל לאחר קביעת הזכאות, וקיום הערכת מצב המטופל פעם בשנה לטיוב הטיפול

רקע לפרויקט

המדריך לרכש חברתי – ספטמבר 2016

המדריך כולל את המלצות הצוות הממשלתי לטיוב האספקה של שירותים חברתיים במיקור חוץ, שגובשו בתהליך שיתוף בין – מגזרי במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

המדריך מבטא, בהתאם להחלטת הממשלה, אמות מידה לשירות חברתי ואיכותו, הגדרת תהליך העבודה, הגברת התחרות טרם תקופת ההתקשרות ובמהלכה והלימה בין תוכן ההתקשרות לבין תוכן הבקרה והפיקוח.

☆☆☆ הגדרת סטנדרטים ומדדים באופן שיביא לשירות מצוין

- סטנדרטים להבטחת בטיחותו וכבודו של מקבל השירות – בטחון קיומי
- סטנדרטים להצלחת השירות – תיאוריית השינוי
- מדדי תוצאה, תפוקה, תשומה

הגדרת היישום למדדים

- שיח עם מפעילי השירות
- תגמול וקנס
- תשלום
- בחירת מפעילי שירותים



המודל הלוגי

של המדריך לרכש חברתי

המדריך לרכש חברתי מעודד בחינה של השרות באמצעות תיאוריית השינוי. תיאוריית השינוי עצמה מתארת את השינוי הרצוי, שצפוי להתרחש עקב התערבות ופעולות מסוימות. במסגרת העבודה בחנו את מערכי התמריצים הנוכחיים במכרז הסיעוד בין היתר על פי המודל הלוגי שמציב המדריך.

המודל הלוגי מציע חלוקה ברורה של השינוי אשר ברצוננו לעשות לתשומות, תפוקות ותוצאות. ליבת המודל עוסקת בשלושת המרכיבים (תשומות, תפוקות, תוצאות), בקשרים וכיצד הם משפיעים האחד על השני, כל זאת בראיית השינוי הרצוי.



מטרת הפרויקט

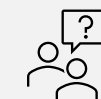
רקע



לגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי זכאי תושב ישראלי מעל גיל הפרישה שנמצא כי הוא זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום, שסכום הכנסותיו לא עובר את הקבוע בחוק ושאינו מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי. במסגרת הזכאות, זכאי הקשיש לגמלה כספית, שעות טיפול בביתו המסופקות על ידי חברת סיעוד ו/או שירותים נוספים.



צורך



כיום, אין מדיניות ממשלתית המקבלת ביטוי אופרטיבי ששמה במרכז את הזקן ומטרתה לדחוק עד כמה שאפשר את תלותו בזולת. זאת ועוד, בקרב הגופים האחראים על הטיפול הסיעודי בקהילה, לא קיים אף גוף אשר תמריצו הכלכלי לשמר את רמת התפקוד של הקשיש.



מטרה



מטרת הפרויקט היא לבחון את המידה שבה מבנה התמריצים הקיים במכרז הסיעוד בקהילה מקדם תכליות של מניעת הידרדרות, שיקום והזדקנות בריאה וגיבוש חלופות למערך תמריצים עתידי אשר יקדם תכליות אלו

שילוב העבודה בפרויקט



שלב ג –

ניתוח מעמיק לחלופות נבחרות

בחינת השלכות, עלויות ואפקטיביות של מספר חלופות נבחרות וכן מיפוי החסמים ליישום החלופות



שלב ב –

גיבוש חלופות תמריצים

גיבוש חלופות עבור מבנה התמריצים העתידי, ניתוח היתרונות והחסרונות של כל חלופה ואופן שילובה במכרז החדש



שלב א –

מיפוי מצב קיים וסקירה משווה

ניתוח מבנה התמריצים הקיים כיום וסקירת מבני תמריצים מובילים בתחום מישראל והעולם

תוצרי השלב:

- ניתוח פתרונות ותמריצים אפשריים לבעיות שעלו בשלב המיפוי
- ניתוח הפתרונות על פי מודל העכביש

תוצרי השלב:

- מיפוי מצב התמריצים הקיים
- סקירה בינלאומית ובישראל
- סקירת ספרות רלוונטית
- סיכום תובנות עיקריות שעלו בתהליך

תוצרים מרכזיים משלב מיפוי המצב הקיים

מיפוי וניתוח בעלי עניין מרכזיים



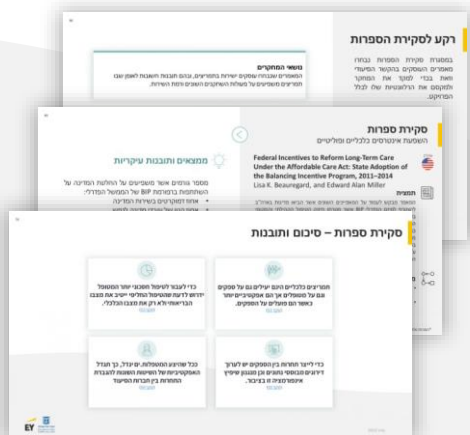
מקרי בוחן מישראל



סקירה בינלאומית



סקירת ספרות



גיבוש תובנות מרכזיות



שיטת העבודה בשלב השני



ריכזנו וניתחנו

ריכזנו את כל התובנות, הבעיות והפתרונות שעלו לאורך התהליך לכדי תוצר מסכם אשר מאפשר למקד את אפשרויות הפעולה לטיוב דחיקת התלות של המטופלים באופן אפקטיבי



נפגשנו

ביצענו מספר פגישות עם צוות הפרויקט המצומצם לחשיבה ועיבוד התוצרים שעלו במהלך העבודה. קיבלנו תגובות ותובנות חשובות שסייעו בהמשך התהליך



מיפוי בעיות ופתרונות

מיפינו את הבעיות שעלו בשלב א' וביצענו תהליך משלים של Top Down לזיהוי אפשרויות לפתרון של בעיות אלו. מרבית הפתרונות מתבססים על עקרונות שעלו בשלב הראשון ועל החומרים שנסקרו



סיעור מוחות

ביצענו סיעור מוחות בתהליך Co-Creation עם מומחי התוכן בצוות הפרויקט הפנימי לטובת הצפת רעיונות ראשוניים מבוססי תובנות שעלו בפרקים השונים של מיפוי המצב הקיים והסקירה המשווה



דיון משותף בפתרונות אפשריים אשר יכולים לקדם מניעת
הידרדרות, שיקום והזדקנות בריאה של המטופל.ת.
לקראת בחירת פתרונות לניתוח העומק בשלב ג'

02. אזורי השפעה ואופן הניתוח

ליבת הבעיה

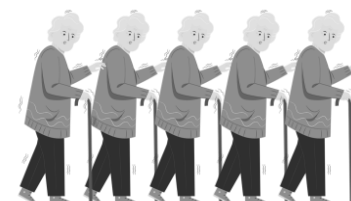
במבנה הקיים של מערכת
הטיפול הסיעודי בקהילה,
לגופים השונים אין תמריץ
לשמר או לשפר את רמת
התפקוד של הקשיש.

שיעור השינוי במספר הזכאים לרמת גמלה נמוכה
שעברו לרמת גמלה גבוהה יותר

2020



2016



3 מכל עשרה קשישים הדרדו
ברמת התפקוד שלהם תוך שנה

1.3 מכל עשרה קשישים הדרדו
ברמת התפקוד שלהם תוך שנה

הנתונים מתוקננים לשינוי מבנה הגמלה אשר התרחש ב-2018.

אזורי השפעה על דחיקת התלות

ליבת הבעיה: דחיקת תלות

אזורי השפעה היקפיים:

תשתית מאפשרת

- ישנו צורך בהגדרה ברורה של טיפול מונע הדרדרות ומקדם בריאות
- ישנו צורך במידע אשר יאפשר מדידה של איכות השירות, השפעתו על מצב המטופלים וכן שינויים ומגמות מתפתחות הקשורות למקבלי הגמלה.

הטמעת הנרטיב של דחיקת תלות בקרב מתווי מדיניות

1 התאמה ומכוונות הטיפול לדחיקת תלות

- אין תמריץ מובנה במרכז לדחיקת התלות של המטופל
- גמלה בכסף אינה מאפשרת מעקב אחר אופן ניצול התקציב ובקרה אחר שימוש לדחיקת תלות
- אין הגדרה של פעולות איכות מונעות הדרדרות והמטפלות/ים אינן מוכוונות לעבר יעד זה

3 מעורבות משפחתית

- בני משפחה אינם תמיד מודעים לאופן שבו הם יכולים לתרום לדחיקת התלות
- בני משפחה אשר מטפלים בזכאים, הן בשכר והן ללא תגמול, אינם בהכרח מוכשרים לתפקיד

5 מוטיבציה ומחבורות המטופל לתהליך

- עקב חוסר במידע ובכלים מתאימים, חלק מהמטופלים מעדיפים ששעות הטיפול ינוצלו לפעולות שאינן מקצועיות ושאינן דוחקות תלות באופן ישיר וכן לעיתים לא מחוברים לתהליך

2 מיומנות הצוות המטפל

- למטפלות אין תמריץ לשפר את המיומנויות המקצועיות שלהן באמצעות הכשרה ו/או השתלמויות
- אין תמריץ מספק וישנו קושי רב בשימור עובדים ותיקים ואיכותיים

4 איכות השירות ההיקפי*

- אין תמריץ מובנה לחברות הסיעוד לשיפור השירות
- אין תמריץ לחדשנות בענף ולשימוש בטכנולוגיה למניעת הדרדרות
- למטפלות ולחברות אין תמריץ לטפל בזכאים מורכבים וקשים היות והשכר הינו אחיד לכלל המטופלים

* איכות השירות למטופל שאינה נגזרת ממיומנות הצוות המטפל או מהתאמת הטיפול

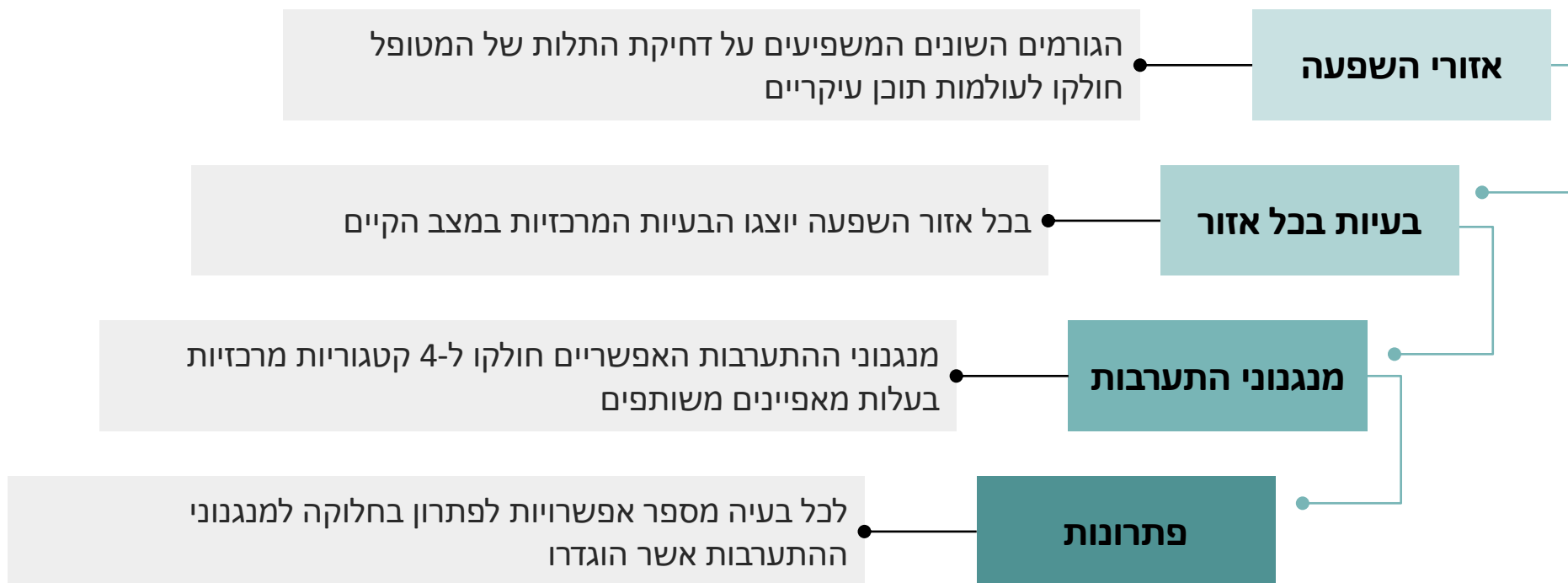
6 מעטפת קהילתית

- אין חיבור בין הטיפול בקהילה (רפואי וסוציאלי) לבין הטיפול הסיעודי הביתי
- אין מעקב קבוע אחר מצבם הבריאותי של הזכאים או של אוכלוסיות הצפויות להזדקק לגמלה

מבנה הניתוח לבעיית דחיקת התלות של המטופל

מטרת העל:

תכנון ויישום מערך פעולות והתערבויות ממשלתיות אשר יתמרצו את המערכת לפעול לדחיקת תלות



סוגי מנגנוני התערבות

להלן 4 קטגוריות של מנגנוני התערבות אשר ניתן להפעיל על השחקנים השונים על מנת לשנות את מיקוד השירות לעבר טיפול דוחק תלות.

 תמריץ שאינו כלכלי (בעיקר עידוד תחרות)	 שינוי מבני	 אסדרה	 תמריץ כלכלי (תשלום/קנס)
פעולות נוספות המעודדות ומייעלות את שיפור הטיפול שאינן תגמול כלכלי ישיר, כגון: פרסום מידע תומך החלטה לציבור	שינוי באופן תשלום הגמלה, במערך הגורמים האחראיים על מתן השירותים או באופן שבו בנוי המנגנון כיום	מעורבות רגולטורית שמסדירה את תחומי האחריות, או מגדירה טיפול או פעולות מוכרחות כחלק מתקנה, חוק או סעיף במכרז	מנגנון המאפשר תגמול או השטת קנס שמעודד את השחקנים השונים לטיפול מיטבי דוחק תלות



דחיקת תלות

מדד הבוחן עד כמה הפתרון המוצע יסייע לקדם מניעת הידרדרות, שיקום והזדקנות בריאה של המטופל



יעילות תקציבית

מדד הבוחן עד כמה התקציב אשר יידרש למימוש הפתרון מנוצל באופן יעיל וההשקעה התקציבית מלווה בתועלת שוות ערך המסייעת להגשמת המטרה



ישימות

מדד הבוחן עד כמה הפתרון פשוט, אפשרי ליישום וכן לא מייצר התנגדות עזה, בנוסף, האם ידרוש שינויי חקיקה ומה סיכויי המימוש שלו במציאות הנוכחית



מודל דירוג פתרונות מעודכן



03. ניתוח בעיות ופתרונות בהתאם לאזורי השפעה

מרכיבי התשתית

הגדרה ברורה במכרז של מדדים הבודקים טיפול איכותי ודרך מדידתם

יצירת מדדים ברורים אשר בודקים את איכות הטיפול של חברות הסיעוד, הגדרתם במכרז ופירוט אופן מדידתם ע"י חברות הסיעוד או גוף חיצוני.



הגדרת דוחות נתונים קבועים המועברים ע"י חברות הסיעוד לביטוח הלאומי

בניית דוחות נתונים אשר ימולאו על ידי חברות הסיעוד וישלחו בתקופה מוגדרת ליצירת מאגר מידע עדכני ומהימן.



בניית מערכת מידע אשר בתוכה ניתן יהיה לנהל ולנתח את כלל המידע הנאסף מהגורמים השונים אודות מקבלי הגמלה ונותני השירותים

בניית מאגר מידע כולל אשר יכיל נתונים מחברות הסיעוד, קופות החולים, בתי החולים ועוד. מאגר זה יאפשר ביצוע מחקרים מבוססי נתונים אשר יוכלו להצביע על תוצאות השירותים, מצב המטופלים ואיכות החברות.



מכרז חיצוני לחברה אשר תהיה אחראית על מדידת איכות הטיפול ותוצאותיו

יצירת מכרז צל לחברה אשר תהיה אמונה על מדידת איכות הטיפול של חברות הסיעוד, תוצאות הטיפול ומצב המטופלים.



תשתית מאפשרת

מידע ומדידה

איסוף מידע ונתונים אודות הטיפול יאפשר מדידה של איכות השירות, השפעתו על מצב המטופלים וכן שינויים ומגמות מתפתחות הקשורות למקבלי הגמלה ושינויים ברמות הזכאות ואופי מתן השירותים.

כיום לא קיימת מדידה מסודרת של השירות הניתן ע"י חברות הסיעוד והשפעתו על המטופלים. כמו כן, לא קיימת מדידה (או ניתוח מעמיק וממצא) של ההשפעות השונות שיש לטיפול אותו מקבלים הזכאים על מצב בריאותם. מדידה של השירות וכן איסוף נתונים על הזכאים ועל השוק יאפשר את טיוב השירות הניתן לאזרח ולמיצוי האמצעים בצורה היעילה והנכונה ביותר.

מרכיבי התשתית

הגדרה של פעולות דוחקות תלות לאחר ביצוע מחקר ע"י גורמי מקצוע בתחום הגריאטרי



הגדרה של מהן הפעולות אשר מקדמות תכליות של מניעת הדרדרות ודחיקת תלות תאפשר הכוונה של כלל המערכת לעבר פעולות אלו

עדכון הפעולות המוגדרות לביצוע ע"י המטפלות בהגדרות הגמלה

הגדרת הפעולות ע"י גורמי מקצוע, יכולה לקדם את הגדרת תפקידי המטפלות. ים כפי שאלו מוגדרים ע"י הביטוח הלאומי בפירוט הזכאות לגמלה



ביצוע מחקר מתמשך אודות השפעת הפעולות שהוגדרו על מניעת הדרדרות ודחיקת תלות



ביצוע מחקר אורך, מבוסס נתונים אמפיריים אודות ההשפעה של הפעולות על הזכאים לגמלה בפועל יאפשר הסקת מסקנות ושיפור הטיפול בטווח הארוך



תשתית מאפשרת דחיקת תלות מקצועית

נדרש לבסס את המידע אודות אפשרויות הטיפול מונע ההידרדרות ומקדם הבריאות

נכון להיום אין מספיק מידע מוגדר אודות טיפול מונע הדרדרות ומקדם דחיקת תלות. הגדרה כזו יכולה לאפשר קביעת יעדים ברורים, תפוקות ומדידת תוצאות והשפעת הטיפול על הזכאים באופן נרחב.

1. התאמה ומכוונות הטיפול

אין תמריץ מובנה במרכז לדחיקת התלות של המטופל

* ניתוח מבנה המרכז, ראיונות שטח

פתרונות אפשריים

תמריץ שאינו כלכלי

פרסום המדדים ודירוג החברות לציבור
פרסום המדדים והדירוג לציבור הרחב עתיד לגרום לחברות לנסות ולשפר את השירות שלהם בכדי לשפר את דירוגן ביחס לחברות האחרות. פרסום מדדים מעודד תחרות לשיפור איכות השירות [מקור: בוצע בפועל בגרמניה. מתוך – סקירה השוואתית של מערכות סיעוד: גרמניה, הולנד, דנמרק וישראל, BEHAVIORAL THINKING Q, ד"ר איל א. אופיר וד"ר איוון קירכגר, יוני, 2021]



שינוי מבני

חלוקה מבנית בין חברות סיעוד הפועלות ברמות גמלה שונות ליצירת התמחות
חלוקה של ענף הסיעוד בין רמות הגמלה הנמוכות ובין רמות הגמלה הגבוהות (5-6) כך שחברות לא יפעלו בכל הרמות אלא לכל קבוצת רמות יהיו חברות המתמחות בה.



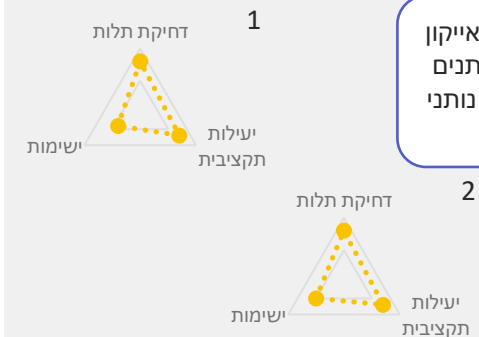
אסדרה

מדידת חברת הסיעוד על ממוצע עמידה ביעדי התוכניות האישיות
לכל מטופל תיקבע תוכנית פעולה אישית ע"י גורמי מקצוע (שאינם מטעם חברת הסיעוד). חברות הסיעוד ימדדו על ממוצע עמידה ביעדי התוכניות האישיות כך שלחברות יהיה תמריץ להכווין את המטפלות לעבר התוכניות האישיות והטיפול דוחק התלות [מקור: קיים במידה מסוימת בהולנד. שלב א – מיפוי מצב קיים: סקירה בינלאומית]



תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

1. בונס למטפלות באמצעות מדידת תפוקות
מדידת עבודת המטפלות באמצעות מדידת תפוקות הטיפול. מטפלות אשר מבצעת פעולות דוחקות תלות תקבל בונס שנתי.
2. בונס לחברות הסיעוד עבור מטופלים שנשארו באותה רמת הזכאות
יצירת מנגנון הבוחן את ממוצע הדרדרות המטופלים בכל החברות ומשווה אותו לממוצע הכללי (בין כל רמה ורמה) ותגמול בהתאם



לאורך המצגת סימנו באייקון זה פתרונות הניתנים ליישום במסגרת מרכז נותני השירותים

גמלה בכסף אינה מאפשרת מעקב אחר אופן ניצול התקציב ובקרה אחר שימוש לדחיקת תלות

* ניתוח מבנה הגמלה הנוכחי

תמריץ שאינו כלכלי

שינוי מבני

יצירת גוף אשר אמון על מעקב וניהול כספי הגמלה

הגדרת גוף אשר אמון על ניהול כספי הגמלה של הזכאים – כל ההוצאות עוברות דרכו והוא אחראי לוודא כי יצאו לצרכים המתאימים

[אוסטרליה והולנד. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

אסדרה

1 הגבלת השירותים הניתנים לרכישה באמצעות כספי הגמלה

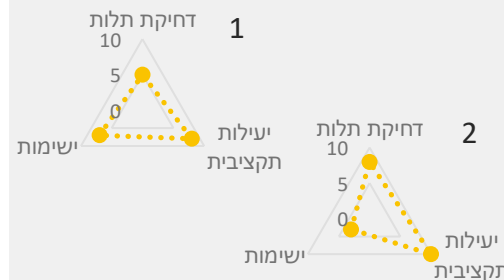
הגדרת סט של שירותים הניתנים לרכישה באמצעות כספי הגמלה אך ככל ששירות/טיפול הינו יותר מכוון לעבר דחיקת תלות כך המטופל יוכל לרכוש ממנו יותר או שמחירו יהיה נמוך ומסובסד
[מקור: אוסטרליה, מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

2 יצירת תעריף לשירותי הגמלה אשר יעודד צריכת טיפולים דוחקי תלות

בניית הגמלה כאסימונים (מה שקורה היום) ללא אפשרות של המרה לכסף, כאשר התמחור של השירותים יעשה ע"פ "רמת" דחיקת התלות שהם מספקים
[מקור: מבוסס על שילוב בין הרפורמה באוסטרליה, בהולנד, וכן מבנה הגמלה הנוכחי בישראל]

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

פתרונות אפשריים



1. התאמה ומכוונות הטיפול

אין הגדרה של פעולות איכות מונעות הדרדרות והמטפלות/ים אינן מוכוונות לעבר יעד זה

* הגדרת הפעולות במכרז, מחקר ברוקדייל

פתרונות אפשריים

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

תשלום על עמידה ביעדי תפוקות על פי תוכנית אישית או בלעדיה

הגדרת תשלום בונס למטפלות ולחברות הסיעוד אשר יעמדו ביעדי התוכנית האישית אשר הוגדרה למטופל. התוכנית תוגדר, בין היתר, באמצעות מדדי תפוקות. המטפלות יבחנו על עמידה ביעדים האישיים של המטופלים ואילו החברות ימדדו על ממוצעים.



אסדרה

יצירת תוכנית פעולה אישית לכל מטופל
לכל מטופל תיקבע תוכנית פעולה אישית ע"י גורמי מקצוע (שאינם מטעם חברת הסיעוד). תוכנית זו תעודכן אחת לקופה או בעקבות שינוי דרסתי במצב המטופל. כמו כן תשמש התוכנית למדידת איכות השירות ותוצאותיו. הבסיס לכל שינוי הינו הגדרה ברורה של פעולות מונעות הדרדרות.
[מקור: הולנד, אנגליה. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]



שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

2. מיומנות הצוות המטפל והמוטיבציה שלו

אין תמריץ מובנה להכשרת מטפלות - הן מצד חברות הסיעוד והן מצד המטפלות עצמן

*ראיונות עם מטפלות וחברות הסיעוד

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

1. תשלום דיפרנציאלי למטפלות
תשלום על שעות הכשרה + תשלום גבוה יותר למטפלות אשר עברו הכשרה, ובכל שמוסיפות קורסים והכשרות נוספות השכר עולה בהתאם
2. תשלום בonus לחברות המעניקות הכשרה מעבר לתקן
הגדרת בonus לחברות אשר יעברו את תקן ההכשרה למטפלות (גם כאשר יקבעו תקן הכשרת חובה לכל המטפלות)

אסדרה

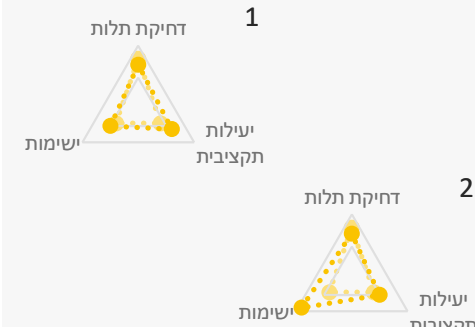
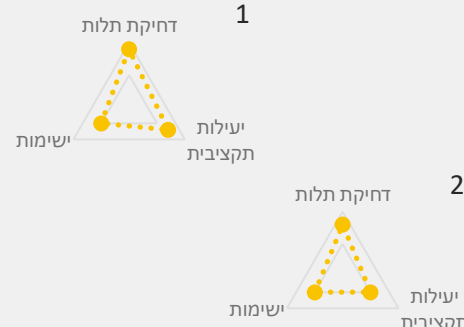
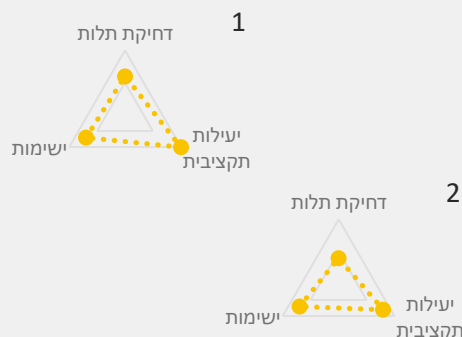
1. הכשרת יסוד מחייבת למטפלות
הגדרת הכשרת יסוד בסיסית אותה מחוייבת לעבור כל מטפלת בתחילת תפקידה. הכשרה זו תועבר ע"י גוף חיצוני או ע"י חברות הסיעוד בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי
[בעיות במיפוי המצב הקיים]
2. הכשרת ייעודית לפי תחומים
בניית מערך הכשרות אשר ייצר התמחות במקצוע הטיפול. לדוגמה – התמחות בטיפול בדמנציה, מצבים סיעודיים מורכבים ועוד.

שינוי מבני

הכשרות על ידי גוף חיצוני לחברות
הכשרות הבסיס למטפלות ינתנו ע"י גוף חיצוני לחברות הסיעוד אשר יתמחה בהכשרה. חברות הסיעוד יוכלו לספק הכשרות מעבר להגדרות החובה ובכך לשפר את השירות אותו הן מספקות ללקוחותיהן ואת תנאי ההעסקה של המטפלות עצמן.

תמריץ שאינו כלכלי

1. דירוג החברות על הכשרת המטפלות
מדידת החברות על רמת ההכשרה של המטפלות מעבר לתקן החובה (בין אם מעבר ל-30% המוגדר במכרז כיום ובין אם מעבר להכשרות היסוד המחייבות שהוצעו בשקף זה) ושימוש בנתון הנאסף לדירוג החברות.
[מקור: ראו 'פרסות מדדים'. נוסף: המדריך לרכש חברתי]
2. חיוב כלפי חברות הסיעוד להציג את רמת ההכשרה של כל מטפלת לפני הגעתה למטופל בפעם הראשונה



2. מיומנות הצוות המטפל והמוטיבציה שלו

אין תמריץ מספק וישנו קושי רב בשימור עובדים ותיקים ואיכותיים

*מיפוי מצב קיים – ראיונות עם המטפלות וחברות הסיעוד

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

מענק התמדה:

תשלום למטפלות אשר יעבדו בענף מעל 3 שנים וזאת על מנת להגדיל את התמריץ להישארות בענף מתוך הבנה כי רוב המטפלות נוטשות את הענף בשנתיים הראשונות לתפקיד
[Provider Incentives and Healthcare Costs: Evidence from Long-Term Care Hospitals. Einav, Finkelstein and Mahoney]



אסדרה

תנאים סוציאליים מוגברים:

יצירת ענף עבודה מתגמל ונעים יותר באמצעות שדרוג התנאים הסוציאליים כדוגמת תשלום על מעבר בין מטופלים, תשלום על ימי חופש ועוד.
[שיחות עם מטפלות וחברות סיעוד]
 עולה גם מתוך טיטת המלצות של צוות *[הוועדה הבין משרדית]*



שינוי מבני

יצירת אופק קידום ודרגות במערכת המטפלות

יצירת מדרג בקרב המטפלות כך שיווצר אופק קידום ברור למטפלות. הדירוג ילווה בשינוי שכר, תחומי אחריות וסגנון העבודה.
[שיחות עם מטפלות, חברות סיעוד וכן מסקנות הוועדה הבין משרדית, דוח בנק ישראל 2018]



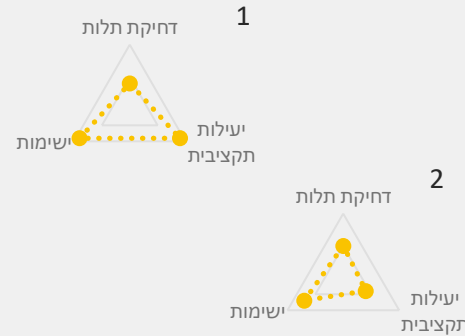
תמריץ שאינו כלכלי

1. דירוג החברות על ותק המטפלות

מדידת החברות על ותק המטפלות אשר מועסקות בחברה ושימוש בתוצאות המדידה לצורך דירוג איכות החברה לאורך חיי ההתקשרות.

2. יצירת מערך תמיכה למטפלות

בניית מערך לתמיכה נפשית במטפלות באמצעות יצירת קבוצות תמיכה קבועות וממומנות לכלל המטפלות.
[שיחות עם מטפלות וחברות סיעוד]



בני משפחה אינם תמיד מודעים לאופן שבו הם יכולים לתרום לדחיקת התלות

* כפי שעלה מנתוני הלמ"ס וראיונות מיפוי המצב הקיים

פתרונות אפשריים

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

מעורבות בני משפחה בתכנון וקביעת תוכנית הטיפול האישית של המטופל
בני המשפחה של המטופל יהיו מעוברים בתהליך קביעת תוכנית הטיפול של המטופל. חלק ממעורבות זו יוכלו לקבל בני המשפחה הדרכה והנחיות כיצד יוכלו לתרום לטיפול ולשפר את מצבו של המטופל

שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

פרסום וחשיפה של בני משפחה לזכויות המטופלים וחלחול הנרטיב של דחיקת תלות
יצירת מערכי מידע וחשיפה של בני המשפחה ובציבור לתחום דחיקת התלות ולזכויות של זכאי הגמלה כך שיעודדו קיום פעולות דוחקות תלות ויוכלו לסייע למצב המטופל גם מחוץ לשעות הטיפול המוגדרות



3. מעורבות משפחתית

בני משפחה אשר מוגדרים כמטפלים בשכר אינם בהכרח מוכשרים לתפקיד

* כפי שעלה מנתוני הלמ"ס וראיונות מיפוי המצב הקיים

תמריץ שאינו כלכלי	שינוי מבני	אסדרה	תגמול כלכלי (תשלום/קנס)
		הגדרת הכשרה מחייבת לבן משפחה מטפל ככל שאר המטפלות. גם בני משפחה מטפלים יהיו מחויבים בקבלת הכשרה בסיסית זו. יש אפשרות לשקול הדרכה מותאמת יותר לבני משפחה אשר מועסקים רק אצל קרוב משפחתם אשר תתמקד במצבו הספציפי של המטופל. [הולנד. מתוך – סקירה השוואתית של מערכות סיעוד: גרמניה, הולנד, דנמרק וישראל, BEHAVIORAL THINKING Q, ד"ר איל א. אופיר וד"ר איוון קירכגסר, יוני, 2021]	תשלום לבני משפחה מטפלים על שעות הכשרה תשלום שכר עבודה על שעות הכשרה בהם ישתתפו בני משפחה מטפלים גם אם לא יהיו מחויבים לעבור את ההכשרה.
		דחיקת תלות  יעילות תקציבית ישימות	דחיקת תלות  יעילות תקציבית ישימות

פתרונות אפשריים

4. איכות השירות ההיקפי

אין תמריץ מובנה לחברות הסיעוד לשיפור השירות

*מסקנה מראיונות עם חברות הסיעוד וניתוח מבנה המכרז

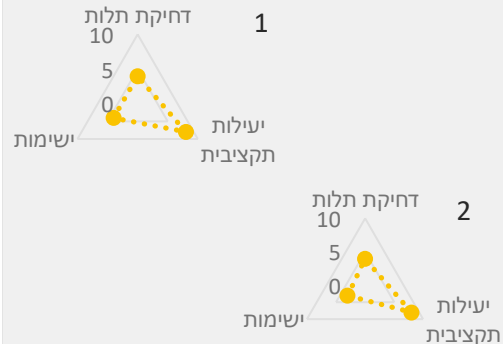
תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

תעריף שונה במכרז ע"פ סלי איכות
חברות הסיעוד ימדדו ע"פ מספר מדדים כדוגמת רמת הכשרה, ותק מטפלות, ממוצע הידרדרות מטופלים בין רמות גמלה ועוד. על פי המדד ידורגו החברות למספר רמות כאשר במכרז עצמו יהיה סעיף בונוס לחברות אשר יקבלו את הדירוג הגבוה



אסדרה

1. הקלת המעבר בין חברות הסיעוד
הקלת הבירוקרטיה של מעבר מטופל בין חברות סיעוד.
[אוסטרליה. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]
2. בחירה מחודשת של חברת סיעוד בכל תקופה
הגדרת תקופה ספציפית בה חברת הסיעוד משרתת את המטופל ולאחר תקופה זו על המטופל לבחור באופן אקטיבי בחברה שברצונו.



שינוי מבני

הגדרת ברירת מחל בבחירת החברות
הגדרת ברירת מחל לחברות נותנות שירותים בכל אזור בהתאם לדירוג שנקבע לחברה. כלומר, החברות אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר יהוו את ברירת המחל במערכת לטיפול בזכאים שלא בחרו חברה באופן פעיל



תמריץ שאינו כלכלי

פרסום המדדים ודירוג החברות לציבור
פרסום המדדים והדירוג לציבור הרחב עתיד לגרום לחברות לנסות ולשפר את השירות שלהם בכדי לשפר את דירוגן ביחס לחברות האחרות. פרסום מדדים מעודד תחרות לשיפור איכות השירות [מקור: בוצע בפועל בגרמניה. מתוך – סקירה השוואתית של מערכות סיעוד: גרמניה, הולנד, דנמרק וישראל, BEHAVIORAL THINKING Q, ד"ר איל א. אופיר וד"ר איוון קירכגר, יוני, 2021]



4. איכות השירות ההיקפי

אין תמריץ לחדשנות בענף ולשימוש בטכנולוגיה למניעת הדרדרות

* ראיונות עם חברות הסיעוד וניתוח השירותים המוצעים

תמריץ שאינו כלכלי	שינוי מבני	אסדרה	תגמול כלכלי (תשלום/קנס)	פתרונות אפשריים
פרסום לציבור של אמצעים טכנולוגיים המשומשים ע"י הספקים פרסום לציבור של הפיתוחים והאמצעים הטכנולוגיים אשר החברות השונות משתמשות בהן לטיפול מיטבי בזכאים. הפרסום יכול לעודד מבני משפחה ומטופלים לפנות לעבר חברות מסוימות ובעקיפין להשפיע על פיתוחים נוספים של חברות הסיעוד 				

4. איכות השירות ההיקפי

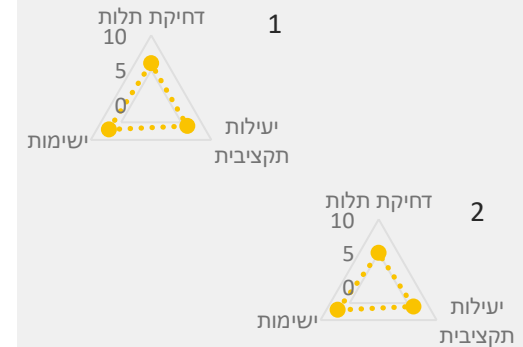
למטפלות ולחברות אין תמריץ לטפל בזכאים מורכבים וקשים היות והשכר הינו אחיד לכלל המטופלים

* ניתוח מבנה המכרז, ראיונות שטח

פתרונות אפשריים

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

- תשלום דיפרנציאלי לפי רמות גמלה**
1. תשלום דיפרנציאלי לחברות הסיעוד לפי רמות הגמלה של הזכאים
 2. תשלום דיפרנציאלי למטפלות עצמן לפי רמות הגמלה של המטופלים איתן הן עובדות.



אסדרה

שינוי מבני

חלוקה מבנית בין חברות סיעוד הפועלות ברמות גמלה שונות ליצירת התמחות

חלוקה של ענף הסיעוד בין רמות הגמלה הנמוכות ובין רמות הגמלה הגבוהות (5-6) כך שחברות לא יפעלו בכל הרמות אלא לכל קבוצת רמות יהיו חברות המתמחות בה.



תמריץ שאינו כלכלי

תמהיל מטופלים אחיד בכל חברות הסיעוד

הגדרה של תמהיל מטופלים אחיד בכל חברות הסיעוד על מנת למנוע מצב של צ'רי פיקינג ע"י חברות הסיעוד



5. מוטיבציה ומחבורות המטופל לתהליך

עקב חוסר במידע ובכלים מתאימים, מטופלים מעדיפים ששעות הטיפול ינוצלו לפעולות שאינן מקצועיות

* שיחה עם ביטוח לאומי, מבנה שירותי הגמלה, ראיונות עם מטפלות וחברות סיעוד

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

מעורבות של המטופל בהגדרת תוכנית הטיפול האישית

המטופל יהיה חלק אינטגרלי מקביעת היעדים לתוכנית הטיפול האישית. מעורבות זו תייצר מחויבות גם בקרב המטופל לתהליך הטיפול ולפעולות אשר יעשו ע"י המטפלת עצמה.

[מקור: רפורמת הסיעוד בהולנד. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

הגבלת השירותים הניתנים לרכישה באמצעות כספי הגמלה

(מפורט באזור השפעה 1)

יצירת תעריך לשירותי הגמלה אשר יעודד צריכת טיפולים דוחקי תלות

(מפורט באזור השפעה 1)



תמריץ שאינו כלכלי

מעורבות המטופל בתהליך

מעורבות של המטופל בתכנון הטיפול בו מביאה למחויבות גדולה יותר, תחושת אוטונומיה וכן ומודעות גדולה יותר [מקור: רפורמת הסיעוד בהולנד. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

שינוי מבני

6. מעטפת קהילתית (טיפול מונע, מעורבות של שירותי קהילה)

אין חיבור בין הטיפול בקהילה (רפואי וסוציאלי) לבין הטיפול הסיעודי הביתי

תמריץ שאינו כלכלי

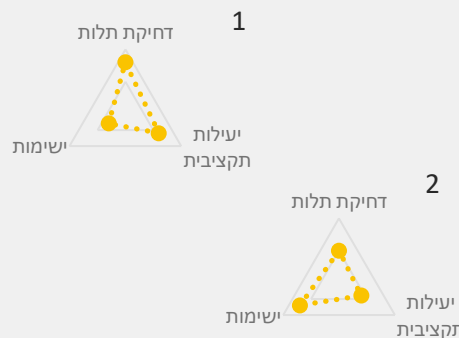
שינוי מבני

1. הגדלת המעורבות של הרשות המקומית בטיפול ובמניעה

הגדלת אפשרויות הפעולה והתקצוב של קהילות תומכות המנוהלות או מפקחות ע"י הרשות המקומית
[רשויות מקומיות מעורבות בתהליך גם בהולנד וגם באנגליה]

2. אירוע חיים סיעוד

בניית פלטפורמה לשיתוף מידע ותיאום בין גורמי טיפול שונים ברמת הרשות המקומית



אסדרה

הגדלת היצע השירותים הקהילתיים אשר ניתן לרכוש במסגרת הגמלה

הכנסת פעולות ותוכניות נוספות לגמלת הסיעוד (כדוגמת טיפולים משלימים, פיזיותרפיה וכו') וכן הגדלת הסבסוד של אפשרויות קהילתיות קיימות כדוגמת קהילה תומכת, מרכזי יום ועוד.



תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אפשרות לסבסוד נרחב יותר למרכזי יום או קהילות תומכות

מרכזי יום וקהילות תומכות יכולות להביא לשיפור מצב הקשישים ומניעת הדרדרות כמו גם מניעה מהגעה למצב סיעודי מלכתחילה. כלומר, ניתן לחשוב על אפשרות של מרכזי יום וקהילות תומכות לאוכלוסיות שצפויות להגיע למצב של הזדקקות לגמלה.

[פעולות מונעות שנעשו באנגליה]



פתרונות אפשריים

6. מעטפת קהילתית (טיפול מונע, מעורבות של שירותי קהילה)

אין איתור מוקדם של זקנים בסיכון להידרדרות וביצוע פעולות מניעה

תמריץ שאינו כלכלי	שינוי מבני	אסדרה	תגמול כלכלי (תשלום/קנס)
	העברת האחריות למעקב אחר מטופלים לרשויות המקומיות או לקופות החולים א. הגדרת אחריות של קופות החולים על מעקב אחר אוכלוסיות מבוגרות באמצעות ביקורים תקופתיים במרפאה או בבית הקשיש ע"י רופא. ב. הגדרת האחריות של הרשות המקומית למעקב אחר מצב הקשישים בתחומה וסיוע בניצול ומימוש זכויותיו	מינוי קייס מנג'ר מינוי של גורם אשר יהיה אחראי על תיק המטופל, תכנון הטיפול, בקרה על התקדמות/הדרדרות המטופל וכן עזרה במיצוי זכויותיו. ניתן להגדיר מספר גופים אשר יספקו קייס מנג'ר: הביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות, חברה חיצונית במרכז צל ועוד	
	דחיקת תלות  ישימות	דחיקת תלות  ישימות	

פתרונות אפשריים

צעדים להמשך

צעדים להמשך



- כינוס תובנות שעלו בדיון ובמהלך השלב
- שלב ג - ניתוח מעמיק של פתרונות נבחרים:
 - ◁ בחירת פתרונות להעמקה כפתיחה לשלב ג
 - ◁ וחידוד המרכיבים בניתוח המעמיק
 - ◁ בחינת השלכות ואפקטיביות
 - ◁ מיפוי החסמים ליישום הפתרונות